

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 11:08:15

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Luis Segundo Altamirano Cisterna **Rut** : 12.282.553-1 **N° Archivo** : A711561
Edad : 50a 5m 16d **Fecha Nacto**: 23/12/1971 **Sexo** : Masculino
Dirección : Nonato Coo 3264 Pob. Mirador De Los An **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 989344347

N° Epicrisis
299686

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 01/03/2022 14:57 **Días Estadía**: 99
Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso) **Fecha Egreso** : 08/06/2022 10:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso del sensorio

Comorbilidades

Tus Oh; Hipertensión Arterial;

Procedimientos

01/03/2022 - Endoscopia Digestiva Alta (Ligadura Varices, Gastrostomia, Biopsias)
13/03/2022 - Traqueostomía
01/03/2022 - Punción Lumbar

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

02/04/2022 - Infec: Neumonía intrahospitalaria - Germen: S.Maltophilia
24/04/2022 - Infec: Neumonía intrahospitalaria - Germen: S.Maltophilia
- Infec: Colonización - Germen: KPC
- Infec: Bacteremia - Germen: Staphylococcus aureus
- Infec: Diarrea intrahospitalaria - Germen: Clostridium Difficile

Resumen Clínico

Fecha de ingreso HSR/UPC: 01/03/2022
Fecha de ingreso UTIM: 16/03/2022
Fecha de ingreso Cuidados especiales: 24/03/2022
Fecha de ingreso hospital de campaña: 06/05/2022
Fecha de ingreso a sala: 17/05/2022
Fecha de Reingreso UTIM: 27/05/2022
Fecha de Reingreso Sala: 01/06/2022

Antecedentes:

-Médicos: hipertensión arterial, trastorno por uso de alcohol crónico.
-Fármacos: Se desconocen.
-Quirúrgicos: clavo endomedular fémur derecho por trauma automovilístico.
-Alergias: No.
-Hábitos: Alcohol 3-4 litros de cerveza y/o destilados al día, tabaquismo 20 cigarrillos/día, drogas no.
-Inmunizaciones: 1 dosis AstraZeneca (octubre/21).
-Hospitalizaciones: no.
-Tutora: Hija (Nicole) 9 68272132

Motivo de consulta: Compromiso de conciencia y convulsiones

Anamnesis:

Paciente con los antecedentes descritos, con múltiples consultas en el servicio de urgencia por constatación de lesiones y epistaxis.

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 11:08

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:42

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 11:08:15

Página 2 de 5

Refieren cuadro de 1 mes de evolución de desorientación, vómitos, conductas erráticas e inestabilidad de la marcha que lleva a caídas recurrentes, con episodios descritos como ¿temblor generalizado, sin compromiso cuantitativo de conciencia.

Consultó en servicio de urgencia del CASR 6 días previo al ingreso, donde se evidencia desorientación temporoespacial e inatención, sin otra focalidad neurológica descrita. Se realizó TAC de cerebro que se describe sin lesiones agudas y se tomó laboratorio general, destacando hiponatremia leve (134 mEq/L), trastorno mixto con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria (pH 7.48, pCO₂ 26 HCO₃ 19) y elevación de GGT (214). Fue dado de alta el mismo día ante ausencia de lesiones traumáticas, con indicación de control en APS y reconsulta en el servicio de urgencia en caso de necesidad.

El día de ingreso presenta episodio con descripción compatible con convulsión tónico-clónica generalizada de duración no precisada. Es llevado por familia al SAPU, trasladado por el SAMU al servicio de urgencias CASR. Ingresó directamente al Reanimador.

A la evaluación primaria en malas condiciones generales, taquicárdico 120 lpm, hipotenso 97/80 mmHg, con requerimientos de oxígeno altos por mascarilla de no recirculación hasta 15 L/min para saturación 92%, con glicemia capilar en 255 mg/dL. Ingresó no reactivo, Glasgow no descrito pero impresiona sin protección de vía aérea, se permeabiliza de forma transitoria con cánula Mayo y se aspiran múltiples secreciones hemáticas. Mal perfundido a distal con Mottling score 4 y llene capilar enlentecido 4 segundos. Evaluación neurológica con pupilas mióticas no reactivas, con reflejo amenaza ausente y corneal presente. Sin lesiones a la exposición y tacto rectal negativo para melena.

Impresiona en shock indiferenciado. Se decide protección de vía aérea con intubación orotraqueal en secuencia rápida de intubación. De forma simultánea se volemita con cristaloides, se inician vasoactivos con noradrenalina (NAD) hasta 0.1 mcg/kg/min, se realiza carga de fenitoína (PHT), se transfunden empíricamente 4 unidades de glóbulos rojos por sospecha de hemorragia digestiva alta y se inicia cobertura antimicrobiana de sistema nervioso central con Ceftriaxona en dosis altas y Aciclovir endovenoso.

Al estabilizarse, se toman exámenes, microbiología, y se realiza endoscopia digestiva alta (EDA) de urgencia, destacando:
- Láctico 182 mg/dL, Hb 20.2 g/dL, GB 30.010, PLQ 313K, PCR 130 mg/L, INR 1.57, TTPa 30 segundos, ELP 145/3.53/103, Calcio 10.7, GSA pH 7.15, pCO₂ 33, pO₂ 58, HCO₃ 11.6, BUN 30, Crea 3.16 mg/dL, BT/BD 1.72/0.77, FA 74, GGT 172, GOT 44, GPT 45, LDH 432, Alb 4.2.

- PL: gram sin bacterias, proteínas 0.48 g/L, Gluc 162, sin células, cultivo pendiente.
- Sedimento de orina (SO) no inflamatorio, urocultivo (UC) y hemocultivos (HCs) pendientes. PCR SARS CoV-2 negativa.
- EDA 01/03: sólo esofagitis y duodenitis que impresionan isquémicas por shock. Sin focos de sangrado activo ni reciente.
- TAC-TAP: focos de condensación en vidrio esmerilado sospechosos de ser virales, atelectasia completa delóbulo inferior izquierdo, nódulo pulmonar superior izquierdo (7mm), catéter venoso central inguinal derecho con extremo distal extraluminal a vena femoral (con edema y gas), esteatosis hepática difusa y quiste cortical renal izquierdo simple (10mm).

Por su gravedad es trasladado a la UPC. Evaluado por neurología, se evalúa TAC de cerebro del 24/02 (6 días previo al ingreso, 1era consulta), observándose hipodensidades talámicas bilaterales y en cabezas de núcleos caudados. Se compara con nuevo TAC de cerebro de ingreso 01/03, evidenciándose mayor extensión de las hipodensidades descritas, nuevas en sustancia gris periacueductal, hipotálamos, tálamo, e hipodensidades limítrofes bilaterales en territorio de arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Les impresiona por historia e imágenes, compatible con encefalopatía de Wernicke, con infartos por hipoflujo en contexto de shock y convulsiones. Sugieren suspender cobertura del sistema nervioso central, mantener Fenitoína y carga de Tiamina.

Diagnósticos de ingreso:

1. Shock indiferenciado
 - a. Séptico / hipovolémico
 - b. obs séptico foco pulmonar
2. Compromiso de conciencia en estudio
 - a. Encefalopatía de Wernicke
 - b. Status convulsivo
 - c. Múltiples ACV isquémicos
3. Insuficiencia renal aguda (AKI) KDIGO III
4. Insuficiencia respiratoria aguda
 - a. Neumonía obs viral
 - b. Atelectasia lóbulo inferior izquierdo.

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 11:08

Página 2 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:42

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

5. Antecedentes

Evolución durante Hospitalización:

- HDN: Shock profundo al ingreso resuelto. Se realiza ecocardiograma para descarte de compromiso cardíaco por déficit de tiamina (Beri-Beri), sin alteraciones relevantes. Evoluciona sin conflicto hemodinámico.

- RESPIRATORIO: Sin mayor conflicto ventilatorio durante uso de ventilación mecánica. Recibe terapia antibiótica por sospecha de neumonía aspirativa vs. viral. Evoluciona del inicio sin conflicto del intercambio, pero con weaning prolongado dado ausencia de vigilia al cese de la sedación, por lo que se realiza traqueostomía (TQT) el 13/03 sin incidentes. Logra paso a modalidades espontáneas, con disminución de soporte hasta consolidar uso de filtro el 15/03. Luego de proceso de decanulación prolongado dado mal manejo de secreciones y compromiso de conciencia, se retira TQT el 28/04/22, persiste con abundantes secreciones pero que resuelven con buena respuesta a atropina sublingual, sin nuevos requerimientos de O2.

- NEUROLÓGICO:

a) Ingresas con sospecha de encefalopatía de Wernicke. Se estudió con electroencefalograma que mostró frecuente lentitud intermitente temporal bilateral independiente, disfunción lenta continua generalizada, sin actividad epileptiforme. Se complementa estudio con Angio Resonancia Magnética Nuclear (RNM) de cerebro que mostró lesiones hemorrágicas bitalámicas, en cabezas de ambos cuadros e hipotalámicas, compatibles con encefalopatía de Wernicke, y lesiones hiperintensas supra e infratentoriales compatibles con focos isquémicos, en contexto de hipoflujo por shock y convulsiones en domicilio. Recibe de forma prolongada Tiamina en dosis de carga por ausencia de respuesta inicial, luego dosis de suplementación.

b) Respecto a los anticonvulsivantes (FAE), que se rota a ácido Valproico por eosinofilia, sin nuevas crisis convulsivas.

c) Tras última evaluación les impresiona pronóstico indeterminado y evolutivo, y sugieren preparado magistral de complejo B y tiamina de mantención, sospecha de demencia de Korsakoff.

d) Evoluciona con episodios intermitentes de agitación que derivan en una caída con golpe en cabeza, sin complicaciones posteriores.

e) Evoluciona con sopor profundo, sin hipoglicemia, sin focalidad, exámenes control que no muestran alteraciones metabólicas que expliquen compromiso de conciencia. Se interpreta en contexto de nueva intercurencia infecciosa y deshidratación.

f) En sala con episodio de miosis de pupilas y pérdida de campo visual, por lo que se solicita TAC de Cerebro que impresiona sin lesiones agudas (sin informe). Dado delirium hipoactivo, sugieren uso de metilfenidato para promover vigilia.

g) Posteriormente en sala evoluciona con disminución del compromiso de conciencia, paciente más vigil, lenguaje coherente, obedece órdenes. Persiste desorientación temporo-espacial, oftalmoplejía, ataxia. No logra marcha sin asistencia dado compromiso mixto neurológico + sarcopénico dada hospitalización prolongada.

INFECCIOSO:

a) Ingresas con sospecha de componente séptico de shock, recibe 4 días de Ampicilina/sulbactam, sin evidencia microbiológica de infección en UC, HCs ni cultiv o de aspirado traqueal de ingreso (CAET), se suspende antibioterapia. Evoluciona a las 24 horas de su suspensión (06/03) febril y con alza de parámetros inflamatorios (PI), recibió cobertura con Vancomicina (3 días) y Meropenem (8), con estudio infeccioso negativo. Evoluciona afebril y con PI a la baja.

b) A su ingreso a UTIM el 16/03 febril, se inicia nuevamente Vancomicina y Meropenem (con uso transitorio de Imipenem por quiebre de stock). Del estudio destaca sólo CAET con C. parapsilosis, interpretado como comensal, y flebitis ulcerada en extremidad superior derecha. Se realiza TAC TAP el 22/03, con nuevas opacidades en lóbulo inferior derecho. Completó 7 días de tratamiento con esquema descrito, con niveles plasmáticos de vancomicina en rango, evolucionando afebril y con parámetros inflamatorios bajos.

c) El 02/04 presenta fiebre y elevación de parámetros inflamatorios, se pancultiva y se inicia Vancomicina y Meropenem, con ambos HCs periféricos (+) para SAMS, y CAET con KPN BLEE 80K UFC, ajustándose terapia a Cefazolina y desestimándose cobertura de KPN por recuento no significativo. Por bacteriemia por SAMS, se controlan HCs negativos el 06/04, considerándose día 0 de antibioterapia. Impresiona como puerta de entrada flebitis de extremidad superior izquierda. Se realiza estudio de diseminación con ecocardiograma transtorácico, con buena ventana, y sin evidencia de vegetaciones. En cintigrama óseo se evidencia fractura en T6 y foco de captación en articulación sacroilíaca izquierda, sospechoso este último de osteomielitis. Se intenta en 2 oportunidades RNM para estudio de foco óseo, frustrados por poca cooperación, se decide no tomar RMN ante buena respuesta a ATB y contraindicación de VMI por decanulación reciente de TQT.

d) Durante última intercurencia presenta 2 episodios de fiebre asociado a elevación de PI. El primero de estos el 09/04 con cobertura empírica inicial con Meropenem y Vancomicina, con orina inflamatoria, UC (-), HCs (-), se rescata nuevo resultado en CAET del 02/04 (+) para S. maltophilia MS, se completa tratamiento con Amikacina por ITU (se considera UC (-) en relación a uso de antibioterapia prolongada) y con Cotrimoxazol por 7 días por neumonía. El segundo de estos episodios el 24/04 con

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 11:08:15

Página 4 de 5

cobertura empírica inicial con Cotrimoxazol, Meropenem y Vancomicina por microbiología previa, con CAET (+) para S.maltophilia MS nuevamente, completando Cotrimoxazol por 10 días, retomando Cefazolina al ajustar esquema.

e) Cursando bacteriemia por SAMS con probable OM por hallazgo en cintigrama óseo en tratamiento con Cefazolina desde el 06/04, con cultivos negativos desde el 09/04 en adelante. Completa más de 6 semanas con Cefazolina, se solicita RNM que muestra hallazgos de cicatrices óseas sacroilíacas por fracturas antiguas. Se suspende antibioterapia, y se solicita evaluación por Infectología quienes sugieren suspender antibioterapia y desestiman ampliar estudio.

f) El 14/05 presenta varios episodios de diarrea acuosa, PCR y toxina CD (+), sin criterios de DACD severa, se inicia tratamiento con vancomicina oral (FI 16/05), por 14 días con buena respuesta.

g) Con cultivo de portación 23/05 con KPC, se solicita traslado a unidad para cohorte.

h) Sin nuevas interurrencias infecciosas.

MEDIO INTERNO: Ingresa cursando AKI KDIGO III recuperada tras volemisación inicial, cursa con hipokalemia severa que se suplementa hasta su resolución. Cursó hipernatremia moderada que fue manejada con SG EV con buena respuesta. Se mantiene sin conflicto del punto de vista nefrológico, última crea 0.56 (28/05/22).

NUTRICIÓN: Recibe nutrición enteral por sonda nasogástrica de forma inicial, asociado a aporte de Tiamina y Folato. Se planteó uso de gastrostomía por pronóstico neurológico incierto, pero tuvo buena evolución fonoaudiológica, permitiendo régimen vía oral. Última medición de balance calorico proteico 35% de los requerimientos, logró desde ese entonces progresión en consistencia, lo que permite aporte de suplementos orales. Pendiente lograr metas de balance calórico proteico con aportes orales. En caso de no lograrlo, plantear el uso de nutrición enteral complementaria.

PSIQUIÁTRICO: Paciente con antecedente de TUS por OH Inicialmente manejado con Lorazepam, se realiza disminución progresiva de benzodiacepinas hasta su suspensión. Tras la suspensión de sedantes el 07/03 evoluciona con delirium hipoactivo marcado, con mínimos periodos de vigilia. Evaluado por neurología, recibe Modafinilo, con excelente respuesta, permitiendo la rehabilitación. Posteriormente presenta episodios de agitación y fluctuación en su estado de conciencia probablemente en contexto de delirium hipoactivo. En planes de reevaluación por especialidad una vez estable.

- DERMATOLÓGICO: Úlcera perianal probablemente en contexto de abundantes deposiciones líquidas, resuelto.

- TMT: Se solicita interconsulta a traumatología para definir manejo de osteomielitis y fractura en T6, sin patología - aguda que requiera tratamiento. Se solicita RNM de cadera que descarta sospecha de OM.

- REHABILITACIÓN:

a) Fonoaudiológico: Inicialmente con régimen cero, con mal manejo de secreciones que contraindican la decanulación. Presenta buena evolución, entrenamiento progresivo y mejoría del estado de conciencia. Logra régimen licuado + líquidos claros. Respecto a la voz, logra buena fonación tras el retiro de traqueostomía.

b) Kinesiológico: en relación a deterioro neurológico nutricional, gravedad inicial y ventilación prolongada, con importante compromiso motor y atáxico. Con terapia progresiva logra sedentar borde cama con asistencia moderada, regular control de tronco, ejercicios en bípedo con asistencia de 1 operador. Recupera fuerza M5 en 4 extremidades, manteniendo aún ataxia.

Plan neurológico:

- Traslado a Policenter hoy para rehabilitación intensiva allá y luego debe ser evaluado en policlínico de Neurología-Cognitivo.

SOCIAL: Red de apoyo: hija, madre y hermano. No cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de sus cuidados al alta. Asistente social al tanto del caso.

Diagnósticos actuales:

Shock indiferenciado resuelto

a.Séptico / hipovolémico

b.obs séptico foco pulmonar

Diarrea por CD en tratamiento

Compromiso de conciencia multifactorial

a.Demencia de Korsakoff

b.Status convulsivo

c.Múltiples ACV isquémicos

Insuficiencia renal aguda (AKI) KDIGO III resuelta

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 11:08

Página 4 de 5

Fecha Última Actualización: 08-06-2022 11:08:15

Página 5 de 5

Insuficiencia respiratoria aguda resuelta
a. Neumonía obs viral
b. Atelectasia lóbulo inferior izquierdo.
Desnutrición
Antecedentes: HTA, TUS OH, tabaquismo.

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía no especificada - De Wernicke

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J: NO

BCG, HDN estable, afebril, sin req O2.
Niega dolor ni otras molestias.
Compromiso de conciencia fluctuante.

Plan Post Alta

Reposo: relativo asistido
Régimen: licuado + pote chico de BSG + líquidos claros con bombilla
O2 para sat 92%
HGT AM
Rehabilitación completa por 2-3 meses con KTM, KTR, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional (si disponibilidad)
Administrar medicamentos partidos, con compota de fruta

Fármacos:

Ácido fólico 5 mg al día VO
Tiamina 30 mg al día VO
Polivitamínico 1 cápsula al día VO
Acido valproico 500 mg cada 8 hrs VO
Quetiapina 25 mg PM VO
Modafinilo 200 mg AM VO
Paracetamol 1 g SOS VO
Haldol 1 mg SOS EV en caso de agitación
Enoxaparina 40 mg al día SC

Controles:

- Control ambulatorio Poli Demencias CDT en 1 mes (familiar debe dejar hora pedida con informe de traslado) en pasillo 9 CDT.
- Seguimiento por APS.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo, Asistido

Régimen Alimentario : Licuado + Pote Chico De Bsg + Líquidos Claros Con Bombilla

Medicamentos :

Controles

S/F - CDT - Neurología Adulto - poli de Demencias

Ignacio José Rodríguez Garcés

INTERNO

Jorge Andrés López Ruiz-Esquide

Becado/Residente

Juan Carlos Claro García-Atance

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 08/06/2022 11:08

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:42

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar